

Р”РёР°РіPSPsP: Колоректальный рак

РџСЪРµРіР°СЪР°С, 1: Кризотиниб

Р’СР ± СЪР°PSPSCРµ РёР»РёPSPёСџРµСГРёРёРµ РёСГРіС«С,Р°PSPёСЦ:

	РќР°Р°РіPSPёРµ	РС,Р°Рі	Р“СЪСРіРіР°Р°	РџPsРіСР»СЦСџРёСЦ	CR	PR	ORR	SD	DCR	PFS	OS
1	MEK and MET Inhibition in Colorectal (NCT02510001)	completed phase1	Dose Expansion Phase	30	0.0	0.0	0.0	23.33	0.0	0.0	0.0
			Dose Expansion Phase	37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.81	5.42

Р’СР ± СЪР°PSPSCРµ PSP°СГСџPSCРµ СГС,Р°С,СЪРё:

Кризотиниб, в сочетании с вемурафенибом, показал быструю и заметную эффективность в лечении колоректального рака с мутацией BRAF (клиническое испытание) [1]. Комбинация биниметиниб/кризотиниб показала плохую переносимость без наблюдения объективных ответов у пациентов с распространенным колоректальным раком RASMT (клиническое испытание; 36 пациентов) [2]. Молекулярно-таргетная терапия кризотинибом вызвала быстрый и устойчивый частичный ответ, но после 15 месяцев произошла диссеминированная прогрессия опухоли (клиническое испытание) [3]. Уровень экспрессии SDHB коррелировал с чувствительностью к препарату кризотиниб (клиническое испытание) [4]. Кризотиниб достиг частичного ответа (PR) с выживаемостью без прогрессирования (PFS) 3 месяца у пациента с mCRC с fusions ALK (отчет о случае; 1 пациент) [5]. Кризотиниб замедлил прогрессирование метастазов печени и перитонеального карциноматоза при колоректальном раке (in vivo) [6]. Кризотиниб в сочетании с MMC показал синергические противораковые эффекты в клеточных линиях CRC и моделях ксенографтов (in-vivo CRC xenograft model) [7]. Кризотиниб заблокировал ось HGF/STAT3/SOX13/с-MET, значительно ингибируя миграцию, инвазию и метастазирование CRC, опосредованное SOX13 (клиническое испытание) [8]. Кризотиниб, в сочетании с цетуксимабом или панитумумабом, значительно снижает количество колоний и ингибирует рост опухоли при колоректальном раке (in vitro и in vivo) [9]. Кризотиниб уменьшил метастазы во всех протестированных моделях при использовании в качестве единственного агента или в комбинации с сунитинибом (in vivo) [10].

РŸРіРёСГРsРё РёСГС,PsCџPSPёРёPsPI:

[1] MET-Driven Resistance to Dual EGFR and BRAF Blockade May Be Overcome by Switching from EGFR to MET Inhibition in BRAF-Mutated Colorectal Cancer. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27325282>

[2] A Phase Ia/b study of MEK1/2 inhibitor binimetinib with MET inhibitor crizotinib in patients with RAS mutant advanced colorectal cancer (MErCuRIC). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40211189>

[3] ROS1 genomic rearrangements are rare actionable drivers in microsatellite stable colorectal cancer. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36053834>

[4] TBX15 and SDHB expression changes in colorectal cancer serve as potential prognostic biomarkers. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38378070>

- [5] Clinical Responses to Crizotinib, Alectinib, and Lorlatinib in a Metastatic Colorectal Carcinoma Patient With ALK Gene Rearrangement: A Case Report. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34036227>
- [6] In vivo imaging xenograft models for the evaluation of anti-brain tumor efficacy of targeted drugs. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29125233>
- [7] Preclinical rationale for combination of crizotinib with mitomycin C for the treatment of advanced colorectal cancer. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28886275>
- [8] SOX13 promotes colorectal cancer metastasis by transactivating SNAI2 and c-MET. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32111984>
- [9] Broad-spectrum receptor tyrosine kinase inhibitors overcome <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30863492>
- [10] HGF/c-Met pathway is one of the mediators of sunitinib-induced tumor cell type-dependent metastasis. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22269210>